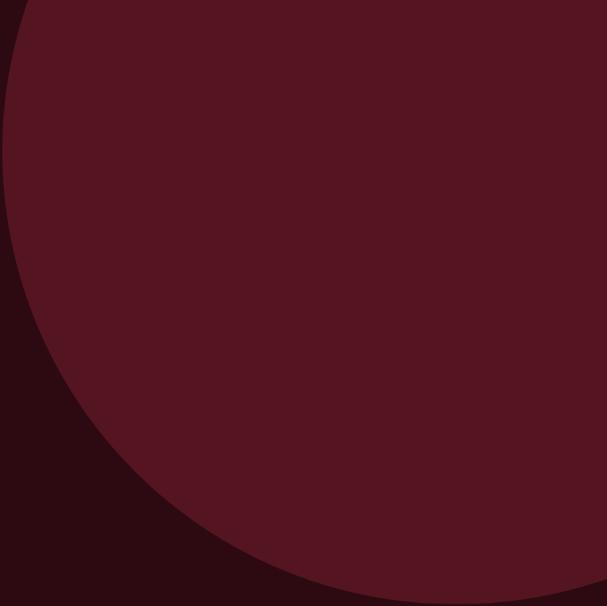




DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 03 DE 12

Como o paciente chega, dilemas dialéticos e teoria biossocial

Ninguém existe fora de contexto: o comportamento nasce de um ciclo transacional entre vulnerabilidade biológica e ambiente — e é por isso que não há culpado único.

ENCONTRO DE SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2026 · 10H ÀS 12H
CONDUZIDO POR JÚLIO GONÇALVES

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **A invalidação também mora na clínica.** Modelos que tentam ajustar a pessoa a uma norma — inclusive TCC mal direcionada — invalidam. A pergunta não é se o comportamento está fora da média, é qual função ele cumpre.
- **Ninguém existe fora de contexto.** O self se define nas relações. Por isso a leitura é transacional: não há paciente zero nem culpado único.
- **Vulnerabilidade emocional tem três fatores biológicos:** sensibilidade ao contexto, intensidade da resposta e velocidade de retorno ao estado basal.
- **A formulação é, por enquanto, uma leitura interna do terapeuta.** Preenchida aos poucos, com evidências da transação entre paciente e ambiente — não é para o paciente participar agora.

01 A cultura da invalidação — inclusive a nossa

O encontro abriu pela filosofia dialética e por um incômodo: a invalidação atravessa a prática clínica. Diversos modelos teóricos, aplicados de forma mal direcionada, acabam tentando encaixar o paciente em normas sociais preestabelecidas em vez de acolher a experiência dele. A TCC não está imune a isso.

O ponto não é abandonar técnica. É reconhecer que, quando o objetivo implícito vira "tornar essa pessoa mais parecida com a média", a intervenção reproduz exatamente o ambiente que produziu o sofrimento.

02 Interdependência: o "eu" não existe isolado

A identidade não é uma coisa que a pessoa carrega dentro de si: ela existe em relação ao contexto. Alguém é mãe, filho, amigo — papéis que só existem na relação com outro. Falar em crenças isoladas, como entidades que moram dentro do indivíduo, simplifica demais.

O mesmo vale para atributos que costumamos tratar como fixos. Inteligência, por exemplo, é construção baseada em médias sociais e de produtividade, não característica intrínseca. O caso de Kaspar Hauser foi usado como ilustração: o desenvolvimento humano é indissociável do estímulo ambiental — não se concebe um indivíduo fora de um contexto.

03 Modelo médico e modelo biossocial

O modelo médico tradicional costuma buscar a redução de comportamentos fora da norma — estereótipias no TEA, impulsividade no TDAH. O modelo biossocial pergunta outra coisa: qual a função disso para essa pessoa? Comportamentos assim frequentemente têm função adaptativa, e suprimi-los sem considerar o contexto pode ser prejudicial.

A armadilha da circularidade

O uso rígido de categorias do DSM ou da CID leva a erros lógicos. O mais comum é o argumento circular: *é borderline porque desregula, e desregula porque é borderline*. O rótulo aparece como explicação, quando é apenas descrição — e uma descrição que muitas vezes invalida a experiência da pessoa.

04 Regulação é individual, não protocolar

A discussão do grupo passou pelo sono. A regra das oito horas noturnas é bem menos universal do que se apresenta: há evidências, na psicologia evolucionista, de variações relevantes nos padrões de sono. O tratamento precisa respeitar o funcionamento biológico de cada pessoa — inclusive de quem trabalha à noite.

O mesmo raciocínio vale para exercício, alimentação e qualquer estratégia de regulação: **o estímulo que regula uma pessoa desregula outra**. Um paciente com TDAH e um paciente com funcionamento borderline podem responder de formas opostas à mesma prescrição. Observar a individualidade vem antes de aplicar o modelo.

05 Ideação suicida como tentativa de alívio

A leitura apresentada foi funcional: a ideação surge diante de um contexto aversivo somado à falta de repertório para mudá-lo. Frequentemente a pessoa não está recusando a vida — está recusando *aquele contexto*. Validar essa dor é parte do trabalho.

Daí a crítica aos contratos de não-suicídio aplicados como fórmula: eles invalidam a experiência e pedem que a pessoa abra mão da única saída que enxerga, sem que outra tenha sido construída.

O QUE ENTRA NO LUGAR

Construir novas habilidades e opções junto com a pessoa, em vez de entregar solução pronta. É a integração dialética: você está fazendo o melhor que pode e precisa fazer

diferente. O trabalho de ampliar repertório acontece fora dos momentos de crise.

06 Construir antes de retirar

O princípio reaparece em vários contextos discutidos. Diante de vínculos abusivos ou indisponíveis que oferecem alívio imediato, a orientação não é remover a fonte de apoio de forma abrupta: é construir novas redes de suporte gradualmente, antes de desvincular do padrão antigo. Retirar o único reforçador disponível deixa a pessoa pior.

No uso de substâncias, o mesmo: a redução abrupta nem sempre é o caminho. Prioriza-se a estabilização e a compreensão da função do uso, construindo motivação sem tirar o suporte que a pessoa tem — salvo risco iminente de morte.

- **Autoeficácia se treina no pequeno.** Tarefas cotidianas simples, como lavar a louça, permitem tolerar desconforto e treinar habilidade sem sobrecarregar o funcionamento atual.
- **Sem motivação, trabalhe no que a pessoa quer.** Foi relatado o abandono de protocolos rígidos em casos sem motivação, deslocando o foco para relações interpessoais ou outro nó de sofrimento.
- **Mexer num nó move os outros.** Num caso com TDAH e altas habilidades, o foco em habilidades interpessoais produziu melhor desempenho social — e uma redução espontânea do uso de substâncias.

07 Vulnerabilidade emocional: os três fatores

A vulnerabilidade emocional foi definida como a combinação de três fatores biológicos:

Sensibilidade

Dispara com pouco: o limiar para que o contexto ative a emoção é mais baixo.

Intensidade

A resposta emocional vem com amplitude maior do que a média.

Retorno lento

A desativação demora. A pessoa permanece ativada por longos períodos.

Quando alta sensibilidade encontra ambiente invalidante, o retorno ao estado basal fica ainda mais lento — e é isso que produz a aparência de crise contínua.

A intensidade também é potência

O funcionamento borderline envolve sofrimento, mas a alta intensidade, canalizada em contexto favorável, permite dedicação profunda a valores, ideais e vínculos. Lealdade e entrega em grau que a média não alcança.

08 O ciclo transacional e o efeito "pisar em ovos"

Gatilhos pequenos — uma mensagem que demora, um esquecimento — podem ser lidos como rejeição e ativar desregulação intensa. A família passa então a evitar certos comportamentos para prevenir explosões. E aqui está a ironia: essa evitação **reforça o padrão**, porque ensina que o comportamento extremo é o que garante a atenção do ambiente.

É a lógica transacional do modelo diátese-estresse: não há culpa unilateral. Cuidadores e pessoa em desenvolvimento se modelam mutuamente, num ciclo contínuo. A causalidade circular é essencial aqui — olhando a história e os contextos passados, fica claro que não existe paciente zero nem culpado único. E isso, para o paciente, reduz o peso da culpa pessoal.

09 Proporcionalidade e modulação

Reações que parecem desproporcionais — uma explosão ao quebrar um copo — são, na verdade, proporcionais ao acúmulo do dia. A pessoa não teve tempo hábil de recuperar a estabilidade entre um evento e outro; o comportamento final é a culminação da sobrecarga, não a resposta ao copo.

MODULAR NÃO É INIBIR

Modulação emocional não se confunde com supressão, inibição ou esquivas. O objetivo é nomear a emoção, ajustar o contexto para reduzir a carga interna e treinar habilidades — direcionamento da atenção, mindfulness — para que a pessoa sinta a emoção sem que ela escale para comportamento desadaptativo.

10 Três protótipos de ambiente invalidante

Caótico

Marcado por negligência e imprevisibilidade.

Perfeito

Focado em desempenho, com ausência de afeto.

Comum

O mais prevalente: desengaja entre a



sensibilidade da criança
e o ambiente familiar.

Uma participante trouxe um relato de infância que ilustra o terceiro tipo: o desejo de comer um bolo, expresso do jeito dela, foi corrigido pela mãe sob a justificativa de "pedir direito". Não havia má intenção — e ainda assim a criança aprende que o seu jeito de ser é errado. Daí vêm a autoinvalidação, a ruminação e a tentativa de adaptação forçada a modelos externos.

O desencaixe também é cultural. A sociedade impõe padrões de felicidade e produtividade inalcançáveis, e isso atinge especialmente meninas, pelo sexismo e por papéis de gênero restritivos. O critério diagnóstico de "raiva inapropriada" foi discutido nessa chave: a raiva é desproporcionalmente invalidada em mulheres, e Linehan argumenta que ela não circula mais nessas pessoas do que outras emoções — é a que a sociedade menos aceita.

11 Os três dilemas dialéticos

O funcionamento borderline foi organizado em três dimensões, cada uma com dois polos opostos. A terapia exige trabalhar a dialética entre eles: escolher um lado da equação trava o progresso.

- **Vulnerabilidade emocional ↔ Autoinvalidação.** De um lado, dor genuína que não é reconhecida; do outro, a tentativa de suprimir esse sofrimento por vergonha. A vinheta apresentada — uma paciente de 26 anos — mostra a oscilação entre a necessidade de contato e a vergonha de ter demonstrado essa necessidade, num ciclo que se retroalimenta.
- **Passividade ativa ↔ Competência aparente.** A passividade ativa ocorre quando a pessoa, por não confiar na própria capacidade de agir — resultado do histórico de invalidação —, mobiliza o ambiente para resolver por ela. A competência aparente é o esforço para parecer regulada e produtiva em contextos específicos, o que oculta a dor profunda e afasta justamente o apoio de que ela precisaria.
- **Crises inexoráveis ↔ Luto inibido.** O luto inibido aparece quando a pessoa evita processar perdas — mortes, mas também perdas simbólicas como carreira ou relacionamentos — porque vive numa sucessão de crises. A sessão passa a ser ocupada pela emergência da semana, e a ferida anterior nunca é elaborada.

12 A formulação de caso

Protocolos rígidos dão lugar a uma leitura personalizada. O uso das ferramentas deve ser idiossincrático, guiado pelo funcionamento do paciente, pela tolerância cognitiva e emocional dele e pela severidade dos riscos.

O preenchimento é **gradual**. Comece pelo básico: queixa principal, lista de problemas e história de desenvolvimento — esta descrita com base nas evidências da transação entre paciente e ambiente, e não como uma cronologia neutra. Na parte inferior entram os alvos secundários, ou seja, os dilemas dialéticos.

Dois cuidados combinados em aula

Os dilemas devem se basear em *observações concretas na sessão e no comportamento do paciente*, não em suposições sobre a vida externa dele. E este é, por ora, um exercício interno do terapeuta: olhar o paciente de outro jeito, sem que ele precise saber ou participar disso agora. Quem atende em TCC pode ir estruturando aos poucos, sem tentar preencher tudo de uma vez.

13 Levar para a prática

MATERIAIS COMBINADOS

Ficaram de ser compartilhados no grupo: o modelo de formulação e material de apoio, artigos ou trechos do manual sobre a leitura transacional, a foto do livro de metáforas citado na aula anterior e o filme sobre o enigma de Kaspar Hauser. Também ficou proposta uma discussão sobre as evidências da psicologia evolucionista a respeito dos padrões de sono.

15 Referências

- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press. — capítulo 2, teoria biossocial e dilemas dialéticos.
- Crowell, S. E., Beauchaine, T. P., & Linehan, M. M. (2009). A biosocial developmental model of borderline personality: Elaborating and extending Linehan's theory. *Psychological Bulletin*, 135(3), 495–510.
- Swenson, C. R. (2016). *DBT principles in action: Acceptance, change, and dialectics*. Guilford Press. Edição brasileira: *Terapia comportamental dialética em ação*.

NOTA DE MÉTODO

Este resumo foi escrito a partir das anotações automáticas do encontro, que sintetizam a discussão em tópicos — não da transcrição literal. Participantes não são identificados: falas, perguntas e o relato pessoal de infância aparecem de forma genérica, e as vinhetas clínicas apresentadas em aula estão sem nomes. A menção a uma formação anterior que simplificava o modelo biossocial foi mantida sem identificar curso ou docente. Padronizei a grafia de Kaspar Hauser, que aparece nas anotações em variação. As referências acima foram conferidas nas fontes originais; os materiais combinados para envio ao grupo ainda não estavam disponíveis quando este resumo foi publicado.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ Construí uma formulação com foco na história de desenvolvimento, com evidências de vulnerabilidade e de ambiente invalidante.
- ☐ Registre os dilemas dialéticos observados na sessão — a partir do comportamento, não de suposições.
- ☐ Pratiquei a leitura de caso com um paciente real, um caso antigo ou um caso de livro.
- ☐ Comecei a monitorar contexto, função e antecedente como pequena mudança prática.
- ☐ Assisti à aula complementar indicada e revisei o conteúdo mais denso.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Descreva um momento da sua prática em que a intervenção pode ter funcionado como invalidação. O que você faria diferente com a lente do modelo biossocial?

02. Explique com suas palavras por que a leitura transacional elimina a busca por um culpado — e o que isso muda na conversa com a família.

03. Num paciente seu, identifique evidências de cada um dos três fatores da vulnerabilidade emocional: sensibilidade, intensidade e retorno lento.

04. Qual dos três dilemas dialéticos você reconhece no caso escolhido na aula 1? Em que comportamento observado na sessão você se baseia?